EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 66483
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 25-06-2023

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: NELLY CLEMENTINA ESPINOZA ZAPATA			RUN	: 6.470.081-2
F.Nac	: 10-02-1949	Edad	: 74 AÑOS, 4 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: AGUA BUENA			Comuna	: NIQUEN
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 91508712		
Fecha Ingreso	: 2023-06-23	Fecha Egreso	: 25-06-2023	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I50.9-INSUFICIENCIA CARDIACA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

SDRA RESUELTO
ICC
ITU POR E. COLI MULTISENSIBLE
HTA
DM2
OBESIDAD

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I50-INSUFICIENCIA CARDIACA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. I10-HIPERTENSION ESENCIAL(PRIMARIA) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. E10-DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

PACIENTE CON ANTEC DE DM TIPO 2 IR, ICC, IC, HTA; OBESIDAD QUE CONSULTA EN S.U. HSC EL 20/06/23 POR CUADRO DE 4 DIAS DE EVOLUCION DE DISNEA A LO QUE SE LE AGREGA DOLOR PRECORDIAL TIPO OPRESIVO, SIN IRRADIACION, SIN OTROS SINTOMAS ASOCIADOS. SE LE TOMA ECG QUE ES DESCRITO COMO RITMO SINUSAL 83 BPM, INTERV PR 154; QTC 421, SIN SIGNOS DE ISQUEMIA. EXAMENES DE LABORATORIO 20/06/23 GLICEMIA 311; CREA 1,4; AC URICO 10,1; COLESTEROL TOT 170; PCR 15,2; BUN 43, UREMIA 92HB/HCTO 12/35.7; GB 6,5; PLAQ 155000; SEGMENT 84%; INR 1,07; DIMERO D 279; TROPO 14; ORINA DE ASPECTO TURBIO, NITRITOS (-), 125 LEU/UL, RX TORAX PA-LAT CON ANGULOS COSTOFRENICOS OCUPADOS, CON MALA DEFINICION DE SILUETA CARDIACA/PACIENTE PERSISTENTE CON REQUERIMIENTOS DE O2 SUPLEMENTARIO, HIPOSATURANDO HASTA 86% AMBIENTAL, MOTIVO POR EL CUAL SE DECIDE HOSPITALIZACION PARA MANEJO DEPLETIVO Y APOYO CON O2 SUPLEMENTARIO.
EN SERV. URGENCIA SE LE COLOCA S.F. PARA MEDIR DIURESIS.
ACTUALMENTE MEJOR, SIN DISNEA, SIN SIGNOS CLINICOS DE CONGESTION, TOLERANDO DE CUBITO, REFIERE SENTIRSE BIEN, SIN REQUERIMIENTOS DE FIO2 SUPLEMENTARIO DESDE HACE 24HRS . SE ENVIA A HODOM PARA COMPLETAR 10 DIASD E ABT PR UROC + PARA E. COLI MULTISENSIBLE

PLAN DE MANEJO:

HODOM POR 7 DIAS PARA COMPLETAR 10 DIAS DE CEFTRIAXONA
RESTRICION HIDRICA Y TRATAMIENTO PARA ICC
CONTROL EN POLI EN 15 DIAS DRA. RIVAS

INDICACIONES AL ALTA

1. MANTENER RESTRICCION HIDRICA 1000CC /24HRS CONTABILIZAR TODOS LOS LIQUIDOS
2. CEFTRIAXONA FRASCO 1 GRAMO 2 frasco cada 24 hrs. por 7 dias via ENDOVENOSA
3. FUROSEMIDA COMPRIMIDO 40 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
4. OMEPRAZOL COMPRIMIDO 20 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
5. CARVEDILOL COMPRIMIDO 6,25 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 12 hrs. por 30 dias via ORAL
6. ISOSORBIDA DINITRATO COMPRIMIDO 10 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 8 hrs. por 30 dias via ORAL
7. HIDRALAZINA COMPRIMIDO 50 MILIGRAMOS 0.5 COMP VO CADA 8HRS

8. INSULINA NPH CARTRIDGE (PENFILL) 100 UI/ML X 3 ML UNIDAD UNIDAD COLOCAR 26UNDS SC AM/ 14UNDS SC PM
9. ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDO 25 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 12 hrs. por 30 dias via ORAL
10. LEVOTIROXINA COMPRIMIDO 100 MICROGRAMOS / DOSIS 0.5 COMP VO DIA
11. QUETIAPINA COMPRIMIDO 25 MILIGRAMOS 0.5 COMP VO DIA NOCHE

Control en: 15 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

Claudia Paola Rivas Pacheco
MEDICO TRATANTE
27781954-6

JEFE SERVICIO